Relatório de Verificação de Manuscrito – RECI

arquivo: Submetido6.docx | formato: DOCX | gerado em: 03/11/2026 15:59
Legenda: A = Atende AP = Atende parcialmente NA = Não atende NSA = Não se aplica - = Não verificado (conferir manualmente)

Item	Descrição	Status	Comentários
CATEGORIA DO MANUSCRITO – Artigo Original			
100	Artigo original: mínimo de 10 e máximo de 25 referências nos últimos 5 anos	NA	9 referência(s) de 2021 em diante (de 25 no total) — mínimo 10
METADADOS			
1	A autoria é composta de, no máximo, 10 autores (exceção em multicêntricos)	-	Não foi possível identificar os autores no manuscrito (esperado: 'Nome Sobrenome1 ORCID 0000-...').
2	Nomes completos sem abreviações	-	Autores não identificados no manuscrito.
3	Links ORCID e Lattes	-	Autores não identificados no manuscrito.
4	Instituição/Afiliação (com cidade e UF)	-	Manuscrito sem autores/afiliações (versão anonimizada?) e folha de rosto não fornecida.
5	Resumo da Biografia (categoria profissional e maior titulação)	-	Folha de rosto não fornecida.
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS			
101	Cópia do Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), com nº de protocolo e data de aprovação	NA	Arquivo não encontrado na pasta de anexos
102	Declaração de Originalidade	NA	Arquivo não encontrado na pasta de anexos
103	Declaração de Responsabilidade e de Transferência de Direitos Autorais preenchida e assinada	NA	Arquivo não encontrado na pasta de anexos
104	Termo de Compromisso de Tradução	NA	Arquivo não encontrado na pasta de anexos
105	Arquivo com sugestão de avaliadores para o manuscrito	NA	Arquivo não encontrado na pasta de anexos
106	Folha de rosto (padrão RECI)	NA	Folha de rosto não enviada
FOLHA DE ROSTO			
109	Apresenta o título do artigo (folha de rosto)	-	Folha de rosto não fornecida.
10	Apresenta título, nome completo dos autores, afiliação, ORCID, lattes e biografia (folha de rosto)	-	Folha de rosto não fornecida.
107	E-mail do autor correspondente	-	Folha de rosto não fornecida.
108	Rede social de todos os autores (preferencialmente Instagram) para divulgação do artigo	-	Folha de rosto não fornecida.
11	São especificadas quais foram as contribuições individuais de cada autor na elaboração do artigo: nome completo de cada autor (em negrito e por extenso), seguido das contribuições.	-	Folha de rosto não fornecida.
FORMATAÇÃO GERAL DO MANUSCRITO			
12	A identificação de autoria do trabalho foi removida do arquivo e da opção Propriedades no Word	A	Nenhuma identificação de autoria nas propriedades do arquivo
13	Está em formato Microsoft Word, digitado em .docx, até 2MB	A	Arquivo .docx com 1.67 MB
14	Redigido na ortografia oficial, fonte Times New Roman 12, com espaçamento 1,5, sem espaçamento entre parágrafos (exceto: Resumo, Figuras, Tabelas e Referências – espaçamento simples)	A	89 parágrafos conferidos: fonte, tamanho e espaçamento corretos. Ortografia oficial não é verificada automaticamente.
110	Itálico para palavras de idioma diferente do manuscrito (ex.: nomes científicos)	A	Nenhum nome científico/expressão estrangeira detectado automaticamente (verificação heurística; confirme manualmente).
16	Deve ser dividido nas seguintes seções: Introdução, Métodos, Resultados, Discussão, Agradecimentos (opcional) e Referências	A	Seções encontradas: Introdução, Métodos, Resultados, Discussão, Referências

Item	Descrição	Status	Comentários
111	Seções INTRODUÇÃO, MÉTODOS, RESULTADOS, DISCUSSÃO, AGRADECIMENTOS e REFERÊNCIAS alinhadas à margem esquerda	A	Títulos das seções alinhados à esquerda
18	Apresenta no máximo 4.000 palavras (da Introdução à Discussão)	A	Total de palavras (3608): Introdução (500), Métodos (1073), Resultados (708), Discussão (1327)
TÍTULOS			
19	Inédito, curto, claro e conciso, identifica o conteúdo do manuscrito, com no máximo 15 palavras	A	Todos os títulos têm no máximo 15 palavras (3 verificados). Ineditismo deve ser conferido manualmente.
23	Títulos nos três idiomas (português, inglês e espanhol), um abaixo do outro	A	Títulos nos três idiomas
20	Título principal em negrito, centralizado, fonte tamanho 12, espaçamento simples	A	Título principal corretamente formatado
21	Títulos secundários em itálico, centralizados, fonte tamanho 12, espaçamento simples	A	2 título(s) secundário(s) corretamente formatado(s)
112	Títulos com apenas a primeira letra em maiúsculo	AP	Título 1: verificar maiúsculas (Unidade, Terapia, Intensiva); Título 2: verificar maiúsculas (Intensive, Care, Unit); Título 3: verificar maiúsculas (Unidad, Cuidados, Intensivos). Pode ser nome próprio (ex.: nome de unidade/instituição); confirme.
RESUMOS			
113	Resumos abaixo dos títulos, com versões nos três idiomas	A	Resumos em português, inglês e espanhol, abaixo dos títulos
24	Conciso, limite máximo de 250 palavras, em parágrafo único, com espaçamento simples entre as linhas	A	Resumos corretos (RESUMO 182 palavras, ABSTRACT 186 palavras, RESUMEN 187 palavras; parágrafo único; espaçamento simples)
25	RESUMO – Justificativa e Objetivos, Métodos, Resultados e Conclusão (versão portuguesa)	NA	'Métodos:' não encontrado; 'Resultados:' não está em negrito
26	ABSTRACT – Background and Objectives, Methods, Results e Conclusion (versão inglesa)	NA	'Background and Objectives:' não está em negrito; 'Methods:' não está em negrito; 'Results:' não está em negrito; 'Conclusion:' não está em negrito
27	RESUMEN – Justificación y Objetivos, Métodos, Resultados e Conclusión (versão espanhola)	NA	'Conclusión:' não encontrado
28	Estruturado e separado nas seções: Justificativa e Objetivos, Métodos, Resultados, Conclusão (todos em negrito, somente a primeira letra em maiúsculo e seguido por dois pontos)	NA	Nenhum dos resumos está estruturado corretamente
DESCRITORES			
30	Apresentados abaixo de cada versão do resumo, citados nos idiomas português, inglês e espanhol	A	Descritores, Keywords e Palabras Clave encontrados abaixo das três versões
31	Apresenta de 3 a 5 descritores, segundo o DeCS/BIREME	A	Descritores: 3; Keywords: 3; Palabras Clave: 3. Conferência no DeCS (decs.bvsalud.org) deve ser manual.
32	Utiliza as terminologias 'Descritores', 'Keywords' e 'Palabras Clave', em negrito, com a primeira letra maiúscula, alinhadas à esquerda	NA	'Palavras-chave' deveria ser 'Descritores'; 'Descritores' não está alinhado à esquerda (justify); 'Palabras clave' deveria ser 'Palabras Clave'
33	Descritores, Keywords e Palabras Clave grifados em itálico, separados por ponto final, com a primeira letra de cada descritor em maiúscula	NA	descritores de 'Descritores' não estão em itálico; descritores de 'Descritores' separados por ponto e vírgula (esperado ponto final); descritores de 'Keywords' separados por ponto e vírgula (esperado ponto final); descritores de 'Palabras Clave' separados por ponto e vírgula (esperado ponto final)
INTRODUÇÃO			
114	O objetivo é coerente com o estudo, destacado no último parágrafo da introdução e iniciado por verbo no infinitivo	A	Objetivo no último parágrafo, com verbo 'compreender'. Coerência com o estudo deve ser avaliada manualmente.
115	O objetivo é idêntico ao apresentado no resumo	AP	69% das palavras-chave do objetivo da Introdução aparecem no objetivo do RESUMO
MÉTODO			
36	Delineamento	-	
37	Cenário estudado	A	Hospital Universitário de município do Sul do Brasil, 2021.

Item	Descrição	Status	Comentários
38	População	A	Idosos (≥60 anos), internados na UTI e com diagnóstico de infecção respiratória comunitária no período de setembro de 2019 a setembro de 2020.
39	Critérios de seleção (inclusão/exclusão)	A	Apenas pacientes com diagnóstico de infecção respiratória comunitária que evoluíram a óbito por sepse, com ou sem covid-19.
40	Fonte de dados	A	Dados disponíveis nos prontuários eletrônicos do Sistema de Gestão da Assistência de Saúde do SUS.
41	Período de coleta dos dados	A	6 meses antes e 6 meses após o início da pandemia de covid-19.
42	Tipo de análise realizada	A	Análise descritiva, incluindo comparações e testes estatísticos para avaliar a normalidade das variáveis e associação entre variáveis de exposição e desfecho. Também inclui análise de dados quantitativos e categóricos. Testes estatísticos incluem Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, qui-quadrado, risco relativo, teste t de Student, teste U de Mann-Whitney e teste de normalidade. Resultados estatísticos são considerados significativos quando p<0,05. Estudo é parte de pesquisa sobre vigilância em saúde, mortalidade e epidemiologia hospitalar, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Campus Uvaranas (CAAE: 99995518.4.0000.0105).
116	Considerações éticas descritas no último parágrafo da seção de métodos	A	Considerações éticas no último parágrafo de Métodos
ASPECTOS ÉTICOS			
117	Para estudos com seres humanos, indica no último parágrafo do método o parecer do CEP	A	Parecer/aprovação do CEP indicado
118	Pesquisa conduzida segundo os padrões éticos — Resoluções 466/2012, 510/2016 ou 580/2018 do Ministério da Saúde	NA	Nenhuma das Resoluções 466/2012, 510/2016 ou 580/2018 foi citada
119	Apresenta o número do protocolo de aprovação e a data de aprovação no CEP	AP	Falta a data de aprovação
120	O número do CAAE foi adicionado nos Métodos	A	CAAE no formato 00000000.0.0000.0000
RESULTADOS			
121	Tabelas e figuras numeradas em ordem sequencial	A	5 legenda(s) em sequência
122	Apresenta tabelas e ilustrações em sequência lógica, com texto complementar a essas (citadas no texto)	A	Todas as tabelas/figuras são citadas no texto
DISCUSSÃO			
123	Utilizaram-se referências, majoritariamente, de manuscritos publicados nos últimos cinco anos, nacionais e internacionais	NA	9/24 referências (38%) de 2021 em diante; nacionais e internacionais
124	Indica no penúltimo parágrafo as limitações do estudo e formas de mitigação	AP	Limitações citadas, mas não no penúltimo parágrafo (parágrafo(s) [14] de 18)
CONCLUSÃO			
53	Não leva conclusão em seção separada, sendo incorporada ao último parágrafo da discussão	NA	Existe seção separada de Conclusão/Considerações finais (artigos originais devem incorporá-la à Discussão)
SÍMBOLOS, ABREVIATURAS E SIGLAS			
125	Acrônimos desconhecidos escritos por extenso na primeira aparição, com a sigla entre parênteses	AP	Siglas sem extenso na primeira aparição (6/15): CID-10, CID-11, RT, IBM, IQR, SIH
126	Termos COVID-19, HIV e AIDS escritos dessa maneira (caso a temática esteja relacionada)	NA	Grafia incorreta: Covid, Covid-19, covid, covid-19 (use COVID-19, HIV, AIDS)
TABELAS, QUADROS E GRÁFICOS			
54	Apresenta no máximo 5 figuras e/ou tabelas, apresentadas no corpo do texto	A	0 tabela(s) e 5 imagem(ns); 5 legenda(s) de tabela/figura/gráfico (total 5)
58	Tabelas são elaboradas no Word (editáveis, não como imagem)	NA	Figura(s) 2, 3, 4 parecem ser tabelas inseridas como imagem — refaça no Word como tabela editável

Item	Descrição	Status	Comentários
127	Tabelas tituladas em cima, alinhadas à esquerda, fonte tamanho 10 e com espaçamento simples	NSA	O manuscrito não contém tabelas
128	Nas tabelas não há linhas entre as variáveis nem linhas de fundo (apenas linhas de topo, cabeçalho e rodapé)	NSA	O manuscrito não contém tabelas
129	Tabelas com espaçamento simples	NSA	O manuscrito não contém tabelas
130	Figuras apresentam boa qualidade (resolução)	AP	1 imagem(ns) entre 96 e 150 dpi. DPI efetivos: 96, 316, 280, 201, 204
61	Figuras tituladas embaixo, alinhadas à esquerda, tamanho 10 e com espaçamento simples	NA	Figura 1: alinhamento justify (esperado à esquerda), fonte 12pt (esperado 10pt), espaçamento entre linhas 1.5 (esperado simples); Figura 2: legenda acima da imagem (deve estar abaixo); Figura 4: alinhamento justify (esperado à esquerda), fonte 12pt (esperado 10pt), espaçamento entre linhas 1.5 (esperado simples); Figura 5: alinhamento justify (esperado à esquerda), fonte 12pt (esperado 10pt), espaçamento entre linhas 1.5 (esperado simples); Figura 5: legenda acima da imagem (deve estar abaixo)
132	Gráficos padronizados na cor preta, preferencialmente em colunas	NSA	O manuscrito não contém gráficos
133	Gráficos titulados em cima, alinhados à esquerda, fonte tamanho 10 e espaçamento simples	NSA	O manuscrito não contém gráficos
131	Títulos de tabelas/figuras com conteúdo explicativo e informação sobre o recorte geográfico e temporal	A	Legendas com conteúdo explicativo, local e período
REFERÊNCIAS AO LONGO DO TEXTO			
134	Citações no texto sobrescritas, sem parênteses, sempre no final do parágrafo, após o ponto final	NA	29× citação antes do ponto final / no meio da frase
135	Referências em ordem sequencial numérica, todas citadas, separadas por vírgula e, em sequências, por hífen (ex.: 7,10-16)	A	25 referência(s) citadas em ordem sequencial
REFERÊNCIAS			
66	Apresentam-se nas Normas de Vancouver	NA	24/25 em formato adequado. Ref 23: formato de autores inválido, ano não identificado
136	Evita citações com os nomes de autores em destaque no texto	A	Nenhuma citação com nome de autor em destaque
69	Referências em fonte 12, espaçamento simples, justificado	A	25 referências formatadas corretamente
137	Apresenta, majoritariamente, 40% de referências internacionais nos últimos 5 anos	NA	7/25 referências internacionais de 2021 em diante (28%); idioma inferido pelo título
71	Apresentam DOI nas referências ou endereço eletrônico	NA	23/25 referências com DOI/URL. Faltam nas refs: 15, 21
72	Autores pelo sobrenome; letra inicial maiúscula, seguida do(s) nome(s) abreviado(s) e sem ponto (ex.: Posma DM, Bill D)	A	25/25 referências com formatação correta de autores
73	Artigos com mais de 3 autores citam os três primeiros nomes antes da expressão 'et al'	A	17 referência(s) com 'et al' formatadas corretamente
VERIFICAÇÃO MANUAL (não automatizável)			
	Redigido na ortografia oficial (revisão ortográfica/gramatical)	-	
	Título inédito, claro e conciso; título cadastrado em inglês na plataforma	-	
	Descritores conforme o DeCS/BIREME (decs.bvsalud.org)	-	
	Introdução breve, com revisão da literatura e justificativa; objetivo coerente com a proposta	-	
	Informações dos Métodos descritas de forma objetiva e completa	-	
	Resultados em sequência lógica; tabelas claras e que transmitem os dados	-	

Item	Descrição	Status	Comentários
	Abreviação dos periódicos conforme Index Medicus/BVS	-	
	Gráficos padronizados na cor preta	-	